

OK

| FLAVIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HD:                           | Esclerose Múltipla                                                                                                                  |
| MEDICO:                       | Dr. Alexandre                                                                                                                       |
| MEDICAMENTOS:                 | Ruan T4, Glyxambi (DM) + Glifage + Stanglit                                                                                         |
| IMC                           | vit D; Desluc (antidiabético)                                                                                                       |
| CIRCUNF. DE PESCOÇO           | Terno; citoneurum (2x mês - vit B12)                                                                                                |
| PA:                           | manevam → Sínd. do coração Antifosfolípico (SAAF)                                                                                   |
| OXIMETRIA:                    | (conhece com hemató) INR                                                                                                            |
| 21/09                         | IPAP = 10 / 21 EPAP = 6 / fexuvantana ; Jua                                                                                         |
| 28/09                         | IPAP = 10 / 21 EPAP = 6 / P.S = 4 / IAH = 2.2 (AC = 1.1) / - Banheiro já ia uma vez. / - melhora da sonolência durante o dia — Jua. |
| 05/11                         | IPAP = 12 / EPAP = 8 / m. de uso: 34.1 / IAH = 1.2 / Jua                                                                            |
| 12/10                         | IPAP = 12 / EPAP = 8 / m. de uso: 5h39 / Jua                                                                                        |
| 18/01                         | P = 12 / 8 cmH <sub>2</sub> O / 22 Mde uso: Ph 26' / IAH = 1.0 / Jua                                                                |
| 19/02                         | P = 12 x 8 cmH <sub>2</sub> O / 22 IAH = 1.2 / m. de uso: Ph 20' / Fuga = 40.7 l/min / Jua                                          |
| 18/03                         | P = 12 x 8 cmH <sub>2</sub> O / U. Auto / 22 IAH = 1.2 / M. de uso: 37.5 l/min. / Jua                                               |

20/05  
22 P=12x8 (4 14x8)  
IAH=0.9  
m. de uso: 6h16

14/06 P=12x8 (4 14x8)  
IAH=1.5  
m. de uso: 7hr

fua.

23 P=12x8  
09 IAH=0.6  
22 m. de uso: 4h10'  
ajusto mais.

fua

26 P=14x8  
08 IAH=2.3  
22 m. de uso: 5h50'

fua

16 P=14x8  
10 m. de uso: 7h8'  
22 IAH=2.1

Bem adaptado, ajuto mais. — fua

12/12 P=14x8 cmH<sub>2</sub>O  
22 IAH=2.1 e/er  
m. de uso: 6hr  
Bem adaptado

Fuga=31.8 l/min

fua

10/02 P=14x8 cmH<sub>2</sub>O  
23 m. de uso: 6hr  
IAH=2.7 e/er  
Relata ter ido viajar e deixou aqui — fua

\*tem escape de ar.

10/04 P=14x8 cmH<sub>2</sub>O  
23 IAH=2.9 e/er  
m. de uso: 6h22'  
Relata que o cachorro comeu o fio do bipap.  
ficou 2 noites s/ uso.

Fuga=8.3 l/min.

fua

12/06 P=14x8 cmH<sub>2</sub>O  
23 IAH=3.1 e/er  
m. de uso: 7hr

mau contato acabou n̄ utili-  
zando o bipap

fua.

15/08 P=14x8 cmH<sub>2</sub>O  
23 IAH=2.6 e/er  
m. de uso=5h24'  
Fuga=8.6 l/min

Relata ter viajado e não  
utilizou

fua



19/10 VPAP / PAP = 14 IAH = 2.7.  
23 EPAP = 8 M. de uso: 6hr  
Barulho fino na cx do umidif. cons-  
tante. fua.

26/01 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O Relata melhora do  
24 Fuga = 18.1 sono.  
IAH = 2.3 elh  
M. de uso: 5h30' fua.

05/04 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O melhora do quadro,  
24 IAH = 3.2 clínico.  
M. de uso: 6h15' fua.  
Fuga = 16.4 lpm.

10/06/24 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O Bem adaptado  
IAH = 3.8 elh Natália  
M. de uso: 6h28m

05/08/2024 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O → Está usando máx  
IAH = 10.0 elh (0.5,8 I# = 2.2) oraral da internet.  
M. de uso = 5h11 pira do sono.  
fuga = 18 l/min \* comprou máx N30: (L) Silas  
marco utorno 1 min  
\* hoje filho

09/09/24 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O PS:5 Bem adaptado  
IAH = 2.6 elh dormindo melhor  
M. de uso = 7h25 min  
fuga = 40.4 l/min \* hoje filho \* Silas

16/12/24 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O PS: 5 cmH<sub>2</sub>O Bem adaptado.  
IAH = 3.5 elh \* hoje filho \*  
M. de uso = 7h23 min FR 18 Silas  
fuga = 38 l/min. VCN 494 ml

12/03 Mudou o medicamento Quetzapido.  
25 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O ↳ Biológico pra EM  
M. de uso = 7h7' a cada 28 dias  
fuga = 21.9 lpm. fua.

18/06/2025 P = 14 x 8 cmH<sub>2</sub>O PS: 5 cmH<sub>2</sub>O \* hoje filho \*  
IAH = 2.7 elh Nisto marcamos Silas  
fuga = 51 l/min  
M. de uso = 6h33 min





**Instituto do Sono**  
Rua Marselhesa, 500 - Vl. Clementino  
São Paulo - SP - CEP 04020-060  
Tel.: (11) 5908-7095

Nome: **FLAVIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE**

Sexo: **M**

Idade: **44** anos

Exame nº: **17443711**

Peso: **79** Kg

Altura: **1,70** m

Data: **02/02/2016**

Médico solicitante: Dr(a). Carlos Henrique Labinas de Oliveira.

**Laudo de Polissonografia: Resultado**

O exame foi iniciado às 22:57 hs e finalizado às 06:27 hs. A latência para início do sono foi de 6,3 min e a latência para o sono REM de 82,5 min. O tempo total de sono (TTS) foi de 385,5 min, com eficiência do sono de 85,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,8% de estágio N1, 52,5% de estágio N2, 23,0% de estágio N3 e 20,8% de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 58,4 min.

Ocorreram 60 despertares, sendo o índice de 9,3 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), sendo 0,0 (nº/h) associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 25, sendo 4 apneias obstrutivas, 1 apneia central, 0 apneias mistas, 7 hipopneias e 13 "RERAs".

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 3,9 (nº/h). O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 1,9 (nº/h), sendo 0,8 apneia/h e 1,1 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO<sub>2</sub>) basal foi de 95,9%, a média de 95,3% e a mínima de 91,0%. O índice de dessaturação foi de 0,8 (nº/h) durante o sono REM e de 1,4 (nº/h) durante o sono NREM. Permaneceu 0,0% do tempo total de sono com SpO<sub>2</sub> abaixo de 90%.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

**IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA**

**Conclusão:**

Índice de apneia e hipopneia e saturação da oxihemoglobina dentro da normalidade.

Registro de ronco leve a moderado e intermitente.

Eficiência do sono normal.

Dra. Luciane I. Luna de Mello  
CRM 98798

Dra. Luciana Palombini  
CRM: 76102



clínico  
**DR. ALBERTO REMESAR**  
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO  
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ  
Certificado em Medicina do Sono  
Faculdade de Medicina de São Paulo  
Médico em Pesquisa e Clínica UFRJ  
Médico em Clínica de Sono UFRJ  
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES  
Medicina do Sono  
Ortopedia e Adv. em Medicina  
CRM-SP: 62.858

## LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Flávio Pereira de Albuquerque  
EXAME nº: 4945  
SOLICITADO POR: Dr. Alexandre Coelho Marques  
DATA: 18/08/2021  
IDADE: 50 anos

### Comentários:

Exame iniciado às 21h59min e concluído às 06h06min. A latência para o sono foi de 11 minutos e a latência para o estágio REM, de 100 minutos. O tempo total de sono foi de 409,5 minutos (06h49min), com eficiência de sono (TTS/TTR)\* de 85%. A distribuição do sono mostrou 10,9% de estágio 1, 43,8% de estágio 2, 24,5% de estágio 3 e 20,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 61 minutos em vigília, ocorreram 120 microdespertares (índice: 17,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 33,6/hora, sendo 5,4 apneia/hora e 28,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 33,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, a média de 93% e a mínima de 85%.

(\*) TTS  $\Rightarrow$  Tempo Total de Sono      TTR  $\Rightarrow$  Tempo Total de Registro

### CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (33,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (33,6/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 66; máxima: 81 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (100 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (85%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 17,6/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (10,9%; normal: 8-10%), 3 (24,5%; normal: 10-12%) e REM (20,8%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (43,8%; normal: 45-55%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 19 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez  
Médico  
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez  
Diretor Técnico Médico  
CRM-SP 69.730

**LAUDO DA  
POLISSONOGRAFIA**

Paciente: Flavio Pereira de Albuquerque

**Solicito:**

1) Polissonografia -----

Ind: Apneia do sono (paciente tem esclerose múltipla estável com medicação modificadora de doença)

CID: G47

18/08 20:00h

Dr. Alexandre C. Marques  
Neurologista  
CRM-SP 16104

**Comentários:**

**CONCLUSÃO:**

Registram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (33,6 horas, índice aumentado acima de 30 horas) e de distúrbio respiratório (33,6 horas), dessaturações de oximetria, ritmo cardíaco sinusal e despansas. As frequências cardíacas foram mínimas: 88 máxima; 81 bpm. O tônus foi contínuo e baixo. Ausência de respiração de Cheyne-Stokes. O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM esteve normal (100 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (83%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado por microdespertares (índice: 17,6 horas; normal até 15 horas). Há um aumento das porcentagens dos estágios 1 (10,9%; normal: 8-10%) e 2 (24,5%; normal: 10-15%) e REM (20,8%; normal: 20%) e redução do estágio 3 (43,8%; normal: 45-55%). Sete momentos perdidos de movimentos rápidos de membros. Escala de Sonolência de Epworth: 19 (anormalidade clínica normal até 9 máxima 24).